RECOMENDACIONES TRAZADORAS

Protocolo de Atención de Personas Agredidas por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia

Se elaboran recomendaciones basadas en el Protocolo de Vigilancia Integrada de la Rabia del Instituto Nacional de Salud, versión 2022, y en los lineamientos nacionales para la atención de personas agredidas por animales potencialmente transmisores de rabia, adaptadas al contexto institucional para fortalecer la identificación, clasificación, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las exposiciones al virus de la rabia.

Recomendación 1: Clasificación adecuada de la exposición al virus de la rabia

Se recomienda que toda persona que consulte por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia sea clasificada como no exposición, exposición leve o exposición grave, de acuerdo con los criterios establecidos en los lineamientos nacionales vigentes.

Responsable: Médico general o profesional de salud responsable de la atención inicial.

¿Cómo? Realizar interrogatorio dirigido y documentar:

- Fecha y hora de la exposición.
- Tipo de exposición:
  - ✓ Mordedura.
  - ✓ Arañazo o rasguño.
  - ✓ Lamedura.
  - ✓ Contacto con mucosas.
  - ✓ Contacto ocupacional.
- Condición del animal:
  - ✓ Observable.
  - ✓ No observable.
  - ✓ Callejero.
  - ✓ Silvestre.
  - ✓ Sospechoso de rabia.
- Localización anatómica de las lesiones.
- Número y profundidad de las lesiones.
- Registrar explícitamente en la historia clínica la clasificación final de la exposición.

Recomendación 2: Identificación de criterios de exposición grave

Se recomienda identificar de forma inmediata las condiciones asociadas con exposición grave debido a su mayor riesgo de transmisión del virus de la rabia y necesidad de profilaxis específica completa.

Responsable: Médico general o médico de urgencias.
¿Cómo? Identificar y registrar si existe:

- ✓ Mordedura en cabeza, cara, cuello, manos, dedos, pies o genitales.
- ✓ Mordeduras múltiples.
- ✓ Lamedura de mucosas.
- ✓ Contacto con murciélagos.
- ✓ Contacto con animales silvestres.
- ✓ Animal con signos compatibles con rabia.
- ✓ Animal confirmado o probable para rabia.
- ✓ Exposición ocupacional a tejido nervioso o material contaminado.

Clasificar como exposición grave cuando se cumpla cualquiera de los criterios establecidos.

Recomendación 3: Lavado exhaustivo de la herida

Se recomienda realizar lavado exhaustivo e inmediato de toda lesión ocasionada por un animal potencialmente transmisor de rabia como medida fundamental para disminuir el riesgo de transmisión viral

Responsable: Médico tratante, profesional de enfermería o personal asistencial encargado de la atención inicial.

¿Cómo?

- ✓ Realizar lavado de la lesión durante 10 a 15 minutos.
- ✓ Utilizar abundante agua y jabón.
- ✓ Valorar necesidad de limpieza adicional y afrontamiento de herida
- ✓ Registrar en historia clínica la realización del procedimiento.

Recomendación 4: Valoración de profilaxis complementaria

Se recomienda evaluar en todos los pacientes la necesidad de profilaxis antitetánica, antibioticoterapia y manejo local de la herida según las características de la lesión.

Responsable: Médico general, enfermería, personal de vacunación.

¿Cómo?

- ✓ Verificar antecedentes de vacunación antitetánica.
- ✓ Evaluar riesgo de infección bacteriana.

- ✓ Formular profilaxis y tratamiento según criterio clínico.
- ✓ Registrar conducta adoptada en la historia clínica.

Recomendación 5: Inicio oportuno de vacunación antirrábica en exposición leve

Se recomienda iniciar de manera inmediata el esquema de vacunación antirrábica en pacientes clasificados con exposición leve.

Responsable: Médico tratante y personal de vacunación.

- ✓ ¿Cómo?
- ✓ Confirmar criterios de exposición leve.
- ✓ Iniciar esquema de vacunación según lineamientos vigentes.
- ✓ Registrar lote, fecha y dosis aplicada.
- ✓ Garantizar programación de dosis subsecuentes.

Recomendación 6: Aplicación de vacuna e inmunoglobulina en exposición grave

Se recomienda iniciar de manera inmediata la profilaxis pos- exposición mediante vacuna antirrábica e inmunoglobulina antirrábica en pacientes clasificados con exposición grave.

Responsable: Médico tratante y personal de vacunación.

¿Cómo?

- ✓ Confirmar criterios de exposición grave.
- ✓ Aplicar vacuna antirrábica según esquema nacional vigente.
- ✓ Calcular la dosis de inmunoglobulina según el biológico disponible.
- ✓ Infiltrar la mayor cantidad posible alrededor de la herida.
- ✓ Aplicar el remanente por vía intramuscular según lineamientos nacionales.
- ✓ Registrar dosis, lote y sitio de aplicación.

Recomendación 7: Notificación obligatoria de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Se recomienda realizar la notificación obligatoria de toda agresión o contacto con animales potencialmente transmisores de rabia mediante la ficha SIVIGILA correspondiente

Responsable: Médico tratante y salud pública

¿Cómo?

- ✓ Diligenciar ficha SIVIGILA 300.
- ✓ Registrar información completa del paciente y del animal agresor.

- ✓ Realizar notificación según los tiempos establecidos.

Recomendación 8: Seguimiento de la observación del animal agresor

Se recomienda garantizar la observación epidemiológica durante 10 días de todo perro o gato agresor identificado.

Responsable: Salud pública y autoridad sanitaria local.

¿Cómo?

- ✓ Registrar condiciones del animal.
- ✓ Coordinar seguimiento durante 10 días.
- ✓ Reclasificar la exposición si el animal presenta signos compatibles con rabia, fallece o desaparece.